HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Причины формирования смешанного типа пищеварения

и что означают ваши жалобы

О чём этот урок

Разбираем, **почему сформировался смешанный тип пищеварения** — что привело к нему в питании, образе жизни и других факторах, — и **откуда берутся ваши жалобы**, с какими состояниями и диагнозами они связаны.

Смешанный тип = вялое пищеварение (активность ЖКТ снижена) + хроническое воспаление в самом ЖКТ или рядом.

1. Две причины смешанного типа

Причина 1. Есть хроническое воспаление

Где	Диагнозы и пояснения
В самом ЖКТ	Хронический гастрит разных типов, дуоденит, воспалительные заболевания кишечника (колит, энтерит), хронический панкреатит
В печени и жёлчных протоках	Хронический гепатит, стеатогепатит, холецистит, синдром Жильбера (формально не воспалительный диагноз, но создаёт предрасположенность к хроническому воспалению)
Удалён жёлчный пузырь	Желчь подтекает в 12-перстную кишку и без контакта с пищей повреждает стенки кишечника — развивается низкоуровневое хроническое воспаление
Системное хроническое воспаление	Проявляется аллергическими реакциями, артериальной гипертензией, аутоиммунными заболеваниями и т. д.

Особенность смешанного типа: воспаление «спящее», низкоуровневое. Оно не проявляет себя постоянно и активно — приступы бывают раз-два в год, что-то слегка поболит. Острого воспаления как такового нет.

Причина 2. Активность пищеварительной системы снижена

Фактор	Почему снижает работу ЖКТ
Длительное хроническое воспаление в ЖКТ	Возможно, главный и единственный фактор. Пока очаг воспаления (гастрит, дуоденит, панкреатит и др.) существует долго, клетки разрушаются — хуже вырабатываются желудочный сок, ферменты поджелудочной и кишечника. Очень распространённая, естественная ситуация
Хронический стресс, переутомление, нарушение режима (недосып, позднее засыпание)	Угнетают работу ЖКТ через нервную систему (см. урок о нервной системе и ЖКТ)
Сидячий образ жизни, гиподинамия, нарушение осанки	«Скукоживаемся» — нарушается кровообращение, органы ЖКТ недополучают питательные вещества
Питание: избыток холодной еды и напитков (из холодильника, комнатной температуры, со льдом), сладкого, тяжёлого, мучного, обволакивающего	Гасят активность ЖКТ
Строгие диеты	Формируют дефициты витаминов группы В (особенно В1), магния, железа, цинка — они нужны для выработки соков и моторики
Привычки: переедание, еда на ночь, лежать и мало двигаться после еды, купание в холодной воде	Гасят активность ЖКТ
Бариатрическая операция	Операции на желудке ухудшают выработку пищеварительных соков
Вторичные причины	Гипотиреоз (гормоны щитовидной железы влияют на моторику); неврозы, вегетативная дисфункция, депрессия (гормоны и нейромедиаторы влияют на ЖКТ); сахарный диабет 2 типа (повреждение сосудов ухудшает питание клеток)
Лекарства: антациды, ИПП, антидепрессанты, бета-блокаторы	В побочных эффектах указано снижение активности пищеварения

Фактор	Почему снижает работу ЖКТ
Возраст	С возрастом естественно снижаются выработка ферментов и моторика. Повлиять нельзя, но можно убрать другие факторы
Конституция с преобладанием доши Капха (Слизь)	Для интересующихся восточной медициной: избыток Капхи — застой, особенно в пищеварительной системе: диспепсия, застой желчи, атонические запоры, вялый язык

2. Почему могло сформироваться воспаление в ЖКТ

Главная причина — ослабление защитных факторов слизистой

Полые органы ЖКТ (пищевод, желудок, 12-перстная, тонкая и толстая кишка, жёлчный пузырь) изнутри покрыты защитным **муциновым и бикарбонатным слоем**. Он защищает стенки от агрессивных веществ: желудочного сока (сильная кислота), желчи (выраженная щёлочь), ферментов поджелудочной — чтобы они «не переварили» сам ЖКТ.

Стресс, недосып, нарушения питания и др. **ослабляют защитные факторы**. Всё остальное — **триггеры**: защита ослабла, а тут добавился острый стресс или патогенная микрофлора — и «вуаля», воспаление.

> **На программе** есть целая группа инструментов для восстановления защиты слизистой: режим (защитные факторы восстанавливаются во сне — важно спать достаточно и вовремя, когда активны гормоны восстановления), травы и специи.

Другие факторы и триггеры

1. **Острый стресс** — подробно в уроках о нервной системе.
2. **Отравления и инфекции:** H. pylori, сальмонелла и другие бактерии, вирусы, простейшие. После инфекции мог сформироваться хронический процесс.
3. **Длительный приём лекарств:** НПВС, глюкокортикостероиды, препараты железа и калия, антибиотики, цитостатики. Нередко вместе с ними назначают защитные препараты (например, ИПП — омепразол), чтобы не повредить слизистую.
4. **Нарушение микробиома кишечника.**
5. **Удаление жёлчного пузыря** — слабое воспаление в кишечнике.
6. **Вторичные:** заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, аутоиммунные болезни, сахарный диабет.
7. **Курение.**
8. **Триггеры в питании:** переедание, избыток жареного, жирного, кислого, алкоголь, кофе, газировка.

Питание — не самостоятельная причина, а спусковой крючок. Готовность к воспалению формируют ослабленная защита слизистой, стресс, инфекции, лекарства. Как правило, работает совокупность факторов.

> **Подумайте,** что из перечисленного актуально для вас. Задачи программы при смешанном типе: убрать низкоуровневое воспаление и не допустить рецидивов — и не менее важно **слегка взбодрить ЖКТ**.

3. Что означают ваши жалобы

Идём сверху вниз — по ходу движения пищи.

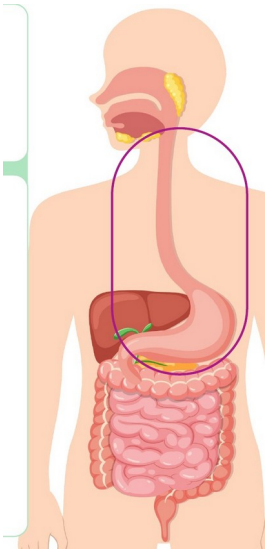
3.1. Язык



Отпечатки зубов на языке; белый налёт

Признак	Что означает
Тонкий белёсый налёт	Переваривание пищи замедлено, снижена активность желудка. Также нарушение микробиома: микробиом един на всех слизистых, и происходящее в желудке и кишечнике влияет на флору полости рта. Язык — зеркало пищеварения
Отпечатки зубов	Язык отёчный. Две причины: сниженная функция поджелудочной (при смешанном типе — с очень высокой вероятностью) и щитовидной железы (не обязательно)

3.2. Пищевод и желудок



Тяжесть после еды, медленное переваривание, переполненность желудка

Что происходит: замедлена эвакуация пищи из желудка — пища находится там дольше нормы; нарушены моторика и выработка соков.

Возможные диагнозы: функциональная диспепсия, гастриты различного типа, атрофия слизистой (сглажена, моторика снижена), гастропарез — замедленное опорожнение желудка.

Отрыжка

Что происходит: самая безобидная причина — быстро едите и заглатываете воздух. Другие — несмыкание («зияние») нижнего пищеводного сфинктера между пищеводом и желудком: повышенное внутрибрюшное давление давит на сфинктеры; замедленная эвакуация пищи.

Возможные диагнозы: ГЭРБ (тогда кроме отрыжки будет и изжога).

Изжога — при смешанном типе возможны все типы у одного человека

Изжога — заброс кислого желудочного содержимого в пищевод. Небольшое число рефлюксов физиологично; изжогу чувствуем, когда их слишком много или пищевод уже повреждён кислотой.

- **На сладкое, жирное, мучное, крахмалистое** — эти продукты тормозят выход пищи из желудка: чем дольше она там, тем выше шанс, что сфинктер разомкнётся.
- **На кислое, жгучее, горькое** — указывает на хроническое воспаление как минимум в пищеводе, возможно в желудке: эти вкусы раздражают слизистую и провоцируют рефлюкс.

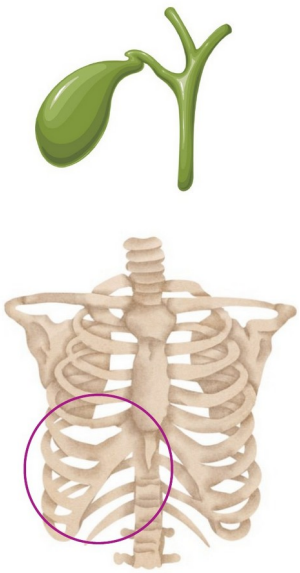
Возможные диагнозы: ГЭРБ, гастропарез; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (выявляют рентгеном). При ГЭРБ желательна ФГДС — есть ли повреждения слизистой пищевода.

Боли натощак, жжение и боли через 1–1,5 часа после еды, боли на алкоголь, кислое, горькое (нечасто при смешанном типе)

Что происходит: боли воспалительного характера — повреждение слизистой желудка. Обычно проявления слабые и эпизодические, обостряются от триггеров в питании (обилие кислого, горького, жгучего).

Возможные диагнозы: поверхностный, эрозивный гастрит, язва желудка (часто в анамнезе).

3.3. Правое подреберье — жёлчный пузырь и протоки



Слабые тупые боли в правом подреберье

Что происходит: не острые, не кинжальные — слабые, распирающие, на уровне дискомфорта, «что-то тянет правый бок». Нарушен отток желчи, особенно при сниженной двигательной активности пузыря.

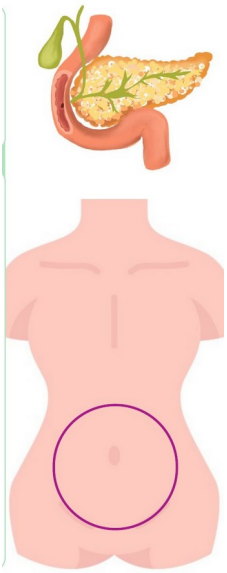
Возможные диагнозы: дискинезия ЖВП (гипокинетическая форма), сладж (застой) в пузыре, хронический холецистит без камней. Риск камней — проверьте жёлчный пузырь.

Колющие, резкие боли в правом боку — после жирного, жареного, большого количества кислого, горького, жгучего

Что происходит: эти продукты провоцируют активное сокращение пузыря; при воспалении или спазме протоков появляются такие боли.

Возможные диагнозы: хронический холецистит, дискинезия ЖВП по гипермоторному типу, жёлчные камни. Если давно не проверяли жёлчный — сходите на УЗИ.

3.4. Центр живота и левый бок — поджелудочная железа



Интенсивное вздутие через 30–60 минут после еды — на смешанную, обильную пищу, жирное и белковое, прохладные напитки

Что происходит: «живот как барабан» — не хватает ферментов поджелудочной и, возможно, кишечника. Вокруг пупка — главный центр переваривания: туда открывается проток поджелудочной, работает желчь (активирует ферменты), выделяются кишечные ферменты. Через 30–60 минут пища как раз приходит сюда — и ей начинает не хватать ферментов.

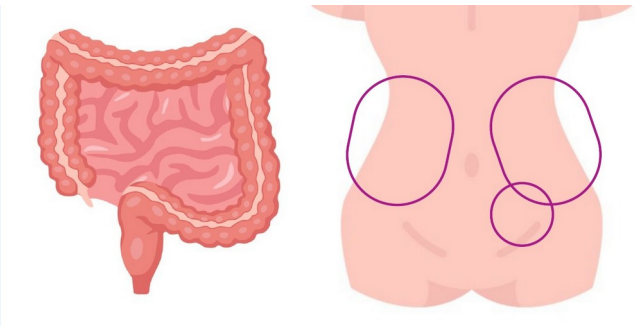
Возможные диагнозы: нарушение желчеоттока (желчь плохо активирует ферменты); снижение функции поджелудочной из-за хронического панкреатита или структурных изменений; врождённые или приобретённые дефекты кишечных ферментов — целиакия, нецелиакийная чувствительность к глютену, нехватка лактазы, избыток фруктозы (фрукты, мёд).

Боли по центру живота и в левом подреберье, опоясывающие, отдающие в спину

Что происходит: классический приступ хронического панкреатита — его ни с чем не перепутаешь: интенсивные боли, усиливаются тяжесть, вздутие, тошнота, нарушения стула. При смешанном типе — редко, раз в год или несколько лет.

Возможные диагнозы: хронический панкреатит.

3.5. Кишечник



Боли или жжение в животе через 1–2 часа после еды

Что происходит: воспалительный процесс в тонкой кишке — к этому времени туда доходит пища.

Возможные диагнозы: дуоденит, язва 12-перстной кишки, энтерит, колит, болезнь Крона.

Регулярное вздутие во второй половине дня (15–16 часов и позже)

Что происходит: нарушены моторика кишечника и микробиом, есть гиперчувствительность кишечника — проблемы с обработкой клетчатки. Не обязательно при смешанном типе, но хроническое воспаление в кишечнике повышает его чувствительность.

Возможные диагнозы: синдром раздражённого кишечника (СРК), дисбиоз.

Жалоба	Что означает
Вздутие и боли на ферментированную пищу и пробиотики (квашеная капуста, кимчи, комбуча, кисломолочное)	Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке — тоже может быть причиной воспаления
Боли и газы от клетчатки: много сырых фруктов и овощей, салаты, капуста, грубая шкурка	«Визитная карточка» СРК — может присоединиться на фоне слабого хронического воспаления
Диарея, несформированный стул, слизь в стуле	Маркер нарушения пищеварения в тонкой и толстой кишке: ВЗК, недостаток ферментов тонкой кишки, гипермоторный жёлчный, СИБР, СРК. Смотрите в сочетании с другими признаками
Запоры — атонические и спастические	Нарушены моторика и микробиом; недостаток клетчатки, жидкости, ферментированных продуктов, стресс, гиподинамия. Запорам посвящён отдельный урок

В следующих уроках — что со всем этим делать.

Вопросы для самопроверки

1. Какие две причины формируют смешанный тип пищеварения?
2. Где может находиться хроническое воспаление при смешанном типе и каковы его особенности?
3. Почему после удаления жёлчного пузыря развивается воспаление в кишечнике?
4. Как длительное хроническое воспаление снижает активность пищеварительной системы?
5. Какие факторы образа жизни и питания снижают работу ЖКТ?

6. Какие вторичные причины и лекарства угнетают пищеварение?
7. Что такое защитные факторы слизистой ЖКТ и почему их ослабление — главная причина воспаления?
8. Какие ещё факторы способствуют воспалению? Почему питание — триггер, а не причина?
9. О чём говорят белый налёт и отпечатки зубов на языке?
10. Что означают тяжесть и переполненность желудка после еды?
11. Каковы причины отрыжки?
12. Какие типы изжоги бывают при смешанном типе и о чём говорит каждый?
13. Чем отличаются слабые тупые боли и колющие боли в правом подреберье?
14. Почему вздутие через 30–60 минут после еды говорит о нехватке ферментов?
15. Как проявляется приступ хронического панкреатита?
16. О чём говорят боли через 1–2 часа после еды и вздутие во второй половине дня?
17. Какие жалобы указывают на СИБР и СРК?
18. О чём говорят диарея и запоры при смешанном типе?